

MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK)

KEPEMIMPINAN DAN PERENCANAAN					
Standar MFK 1					
Rumah sakit mematuhi peraturan dan perundang-undangan tentang bangunan, perlindungan kebakaran, dan persyaratan pemeriksaan fasilitas.					
Maksud dan Tujuan MFK 1: lihat SNARS 1					
Direktur rumah sakit dan pimpinan lainnya bertanggung jawab untuk perundang - undangan dan persyaratan lainnya yang berlaku bagi fasilitas rumah sakit baik yang merupakan regulasi di tingkat nasional maupun tingkat daerah menerapkan persyaratan yang berlaku, termasuk mempunyai izin dan atau sertifikasi sesuai peraturan perundangan, antara lain izin-izin tersebut dibawah ini :					
a) izin mengenai bangunan b) izin operasional rumah sakit yang masih berlaku c) Sertifikat laik fungsi (SLF) bila diperlukan d) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) e) izin genset f) izin radiologi g) sertifikat sistem pengamanan/pemadaman kebakaran h) sistem kelistrikan i) izin incinerator (bila ada) j) izin tempat pembuangan sementara bahan berbahaya dan beracun (TPS B-3) k) izin lift (bila ada) l) izin instalasi petir m) izin lingkungan					
Elemen Penilaian MFK 1	Telusur			Skor	
1. Direktur rumah sakit dan mereka yang bertanggung jawab terhadap manajemen fasilitas di rumah sakit, mempunyai dan memahami peraturan perundang - undangan dan persyaratan lainnya yang berlaku untuk bangunan dan fasilitas rumah sakit. (D,W)	D	Bukti kumpulan dan daftar dan peraturan perundang - undangan yang dimiliki rumah sakit	10 5 0	T L T	
	W	Direktur rumah sakit/Tim K3/Bagian Umum/Kepala IPSRS		T T	
2. Direktur rumah sakit menerapkan persyaratan yang berlaku dan peraturan perundang – undangan. (D, W)	D	1) Bukti kumpulan izin yang masih berlaku 2) Bukti kalibrasi 3) Bukti hasil pemeriksaan dari luar RS	10 5 0	T L T	
	W	Bagian Umum/Kepala IPSRS		S T T	
3. Rumah sakit mempunyai izin-izin sebagaimana diuraikan a) sampai dengan m) di maksud dan tujuan sesuai fasilitas yang ada di rumah sakit dan sesuai peraturan perundang-undangan. (D,W)	D	Bukti daftar dan perizinan yang berlaku Bagian Umum/Kepala IPSRS	10 5 0	T L T	
	W			S T T	

Elemen Penilaian MFK 2	Telusur		Skor	
1. Ada program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan yang dapat terjadi pada pasien, keluarga, staf dan pengunjung, tertulis, meliputi risiko yang ada a) sampai f) di maksud dan tujuan yang merupakan satu program induk atau beberapa program terpisah serta ada regulasi untuk menerapkan program manajemen meliputi 1) sampai dengan 2) di maksud dan tujuan (R)	R	Program tentang manajemen risiko fasilitas dan lingkungan meliputi risiko yang ada a) sampai f) di maksud dan tujuan	10 - 0	TL - T T
2. Program tersebut masih berlaku dan sudah diterapkan sepenuhnya(D,W)	D W	1) Bukti program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan masih berlaku 2) Bukti penerapan program Penanggung jawab program manajemen risiko/K3 RS	10 5 0	T L T S T T

3. Ada bukti peninjauan dan pembaharuan program-program tersebut bila terjadi perubahan dalam lingkungan rumah sakit, atau sekurang-kurangnya setiap tahun. (D,W)	D W	Bukti review program manajemen risiko Penanggung jawab program manajemen risiko/K3 RS	10 - 0	TL - T T
4. Ada bukti tenant/penyewa lahan di dalam lingkungan rumah sakit sudah mematuhi semua aspek program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan yang teridentifikasi dalam a) sampai d) di maksud dan tujuan. (D,W)	D W	Bukti audit: 1) Bukti form ceklis 2) Bukti pelaksanaan audit • Penanggung jawab program manajemen risiko/K3 RS • <i>Tenant/penyewa</i> lahan	10 - 0	TL - T T
Standar MFK 3 Ada individu atau organisasi yang kompeten yang ditugasi untuk melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan. Maksud dan tujuan MFK 3 : Lihat SNARS 1 Pengawasan yang dilakukan individu atau organisasi tersebut meliputi: a) mengawasi semua aspek program manajemen risiko b) mengawasi pelaksanaan program secara konsisten dan berkesinambungan c) melakukan edukasi staf d) melakukan pengujian/testing dan pemantauan program e) secara berkala menilai ulang dan merevisi program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan f) menyerahkan laporan tahunan kepada direktur rumah sakit. g) mengorganisasikan dan mengelola laporan kejadian/insiden, melakukan analisa dan upaya perbaikan.				
Elemen Penilaian MFK 3		Telusur	Skor	
1. Rumah sakit telah menetapkan individu atau organisasi yang kompeten yang ditugasi mengawasi perencanaan dan penerapan program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan yang meliputi a) sampai dengan g) di maksud dan tujuan. (R)	R	Regulasi tentang penetapan penanggungjawab manajemen risiko fasilitas dilengkapi dengan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang	10 - 0	TL - T T
2. Rumah sakit mempunyai program pengawasan terhadap perencanaan dan penerapan manajemen risiko yang disusun oleh individu atau organisasi yang ditunjuk yang meliputi a) sampai dengan g) di maksud dan tujuan. (R)	R	Program pengawasan terhadap manajemen risiko	10 - 0	TL - TT

3. Ada bukti bahwa individu atau organisasi yang ditunjuk sudah mengikuti pelatihan manajemen risiko rumah sakit. (D,W)	D W	Bukti sertifikat pelatihan manajemen risiko dalam file kepegawaian Penanggung jawab program manajemen risiko/K3 RS	10 - 0	TL - TT
4. Ada bukti bahwa individu atau organisasi yang ditunjuk tersebut telah melaksanakan kegiatan yang diatur di a) sampai dengan g) di maksud dan tujuan. (D,W)	D W	Bukti laporan kegiatan penanggung jawab program Penanggung jawab program manajemen risiko/K3 RS	10 5 0	TL TS TT
KESELAMATAN DAN KEAMANAN				
Standar MFK 4 Rumah Sakit mempunyai program pengelolaan keselamatan dan keamanan melalui penyediaan fasilitas fisik dan menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien, keluarga, pengunjung dan staf.				
Maksud dan tujuan MFK 4 : Lihat SNARS 1				
Elemen Penilaian MFK 4	Telusur		Skor	
1. RS mempunyai regulasi termasuk program tentang pengelolaan keselamatan dan keamanan yang meliputi a) sampai dengan f) di maksud dan tujuan. (R)	R	Regulasi tentang: 1) Pedoman pengorganisasian unit kerja yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan 2) Program keselamatan dan keamanan RS	10 5 0	T L T S T T
2. Ada unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keselamatan dan keamanan. (D,W)	D W	Bukti penetapan unit kerja disertai pedoman pengorganisasian • Penanggung jawab program manajemen risiko/K3 RS • Bagian umum	10 5 0	T L T S T T
3. RS telah melakukan identifikasi area-area yang berisiko mempunyai <i>risk register</i> (daftar risiko) yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan fasilitas. (D,W)	D W	Bukti daftar risiko (<i>risk register</i>) keselamatandan keamanan • Penanggung jawab program manajemen risiko/K3 RS • Bagian umum	10 5 0	T L T S T T
4. Regulasi pemberian identitas pada penunggu pasien, pengunjung (termasuk tamu), staf rumah sakit, pegawai kontrak dan semua orang yang bekerja di rumah sakit sudah diimplementasikan (lihat juga SKP1). (D,O,W)	D O W	Bukti identitas yang diberikan kepada penunggu pasien, pengunjung (termasuk tamu), staf rumah sakit, pegawai kontrak dan semua orang yang bekerja di rumah sakit Lihat penggunaan identitas pada penunggu pasien, pengunjung (termasuk tamu), staf rumah sakit, pegawai kontrak • Staf RS • Satpam	10 5 0	T L T S T T

Elemen Penilaian MFK 4.1	Telusur		Skor	
1. RS mempunyai regulasi yang mengatur tentang asesmen risiko pra konstruksi (PCRA) <i>(Lihat juga PPI 7.5)</i> (R)	R	Regulasi tentang asesmen pra konstruksi	10 - 0	TL - T T
2. RS melakukan asesmen risiko pra konstruksi (PCRA) bila ada rencana konstruksi, renovasi atau demolis/ pembongkaran yang meliputi a) sampai h) di maksud dan tujuan. (D,W)	D W	Bukti pelaksanaan asesmen risiko pra konstruksi(PCRA) • Bagian umum/IPSRS/Unit kerja • Komite PPI/PCN	10 5 0	T L T S T T

3. RS mengambil tindakan berdasarkan hasil asesmen risiko untuk meminimalkan risiko selama pembongkaran, konstruksi dan renovasi. (D,O,W)	D O W	Bukti pelaksanaan tentang hasil tindak lanjut PCRA Lihat lokasi pembongkaran, konstruksi dan renovasi (bila ada) • Bagian umum/IPSRS/Unit kerja • Komite PPI/PCN	10 5 0	T L T S T T
4. RS memastikan bahwa kepatuhan kontraktor dipantau, ditegaskan, dan didokumentasikan (lihat juga MFK 3). (D,O,W)	D O W	Hasil audit kepatuhan kontraktor terhadap implementasi PCRA meliputi: 1) Bukti form ceklis 2) Bukti pelaksanaan audit Lihat lokasi pembongkaran, konstruksi dan renovasi (bila ada) • Bagian umum/IPSRS/Unit kerja • Komite PPI/PCN	10 5 0	T L T S T T
Standar MFK 4.2 RS merencanakan dan menyediakan anggaran untuk perbaikan sistem-sistem penting bangunan atau komponen-komponen lainnya berdasarkan hasil pemeriksaan fasilitas dan peraturan perundangan serta anggaran untuk mengurangi risiko sebagai dampak dari renovasi, konstruksi dan penghancuran /demolis bangunan.				
Maksud dan tujuan MFK 4.2 : Lihat SNARS 1				
Elemen Penilaian MFK 4.2		Telusur		Skor
1. RS menyediakan anggaran untuk	D	Bukti tentang tersedia anggaran	10	TL
memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait fasilitas RS (lihat juga AP.5 dan AP.6) (D,W)	W	Kepala Keuangan/Kepala Perencanaan	- 0	- TT
2. RS menyediakan anggaran untuk meningkatkan, memperbaiki atau mengganti sistem, bangunan, atau komponen yang diperlukan agar fasilitas tetap dapat beroperasi secara aman dan efektif. (D,O,W)	D O W	Bukti tentang tersedia anggaran untuk meningkatkan, memperbaiki atau mengganti sistem, bangunan Lihat kondisi gedung dan fasilitas Kepala Keuangan/Ka IPSRS/Bagian umum	10 5 0	TL TS TT
3. Rumah sakit menyediakan anggaran untuk penerapan PCRA dan ICRA bila ada renovasi, konstruksi dan pembongkaran (D,W)	D W	Bukti tentang tersedia anggaran untuk pelaksanaan PCRA dan ICRA • Kepala Keuangan/Ka IPSRS • Komite PPI/PCN	10 5 0	TL TS TT
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN				
Standar MFK 5 RS memiliki regulasi tentang inventarisasi, penanganan, penyimpanan dan penggunaan serta pengendalian /pengawasan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan				

Maksud dan tujuan MFK 5 : Lihat SNARS 1 RS mempunyai regulasi yang mengatur:

- a) data inventarisasi B3 dan limbahnya yang meliputi jenis, jumlah, dan lokasi;
- b) penanganan, penyimpanan, dan penggunaan B3 dan limbahnya;
- c) penggunaan alat pelindung diri (APD) dan prosedur penggunaan, prosedur bila terjadi
- d) tumpahan, atau paparan/pajanan;
- e) pemberian label/rambu-rambu yang tepat pada B3 dan limbahnya;
- f) pelaporan dan investigasi dari tumpahan,eksposur(terpapar), dan insiden lainnya;
- g) dokumentasi, termasuk izin, lisensi, atau persyaratanperaturan lainnya;
- h) pengadaan/pembelian B3, pemasok (supplier) wajib melampirkan material safety data
- i) sheet / lembar data pengaman (MSDS/LDP)

Elemen Penilaian MFK 5	Telusur		Skor	
1. RS mempunyai regulasi yang mengatur B3 dan limbahnya sesuai katagori WHO dan peraturan perundangan, meliputi a) sampai g) di maksud dan tujuan (Lihat juga AP.5.3.1; AP.5.6; AP.6.3; AP.6.6 dan PKPO.3). (R)	R	Regulasi tentang pengelolaan bahan B3 dan limbahnya termasuk MFK 5.1 EP 1	10 - 0	TL - TT
2. RS mempunyai daftar B3 dan limbahnya lengkap dan terbaru sesuai kategori WHO dan peraturan perundang-undangan meliputi jenis, lokasi, dan jumlah dari semua bahan berbahaya dan beracun dan limbahnya. (lihat juga AP.5.5, dan AP.6.6) (D,O,W)	D O W	Bukti berupa daftar B3 dan limbahnya meliputi jenis, lokasi, dan jumlahnya Lihat tempat penyimpanan B3 dan limbahnya • Penanggung jawab program manajemen risiko/K3 RS • Penanggung jawab unit kerja terkait	10 5 0	TL L T S T T
3. Ada bukti bahwa untuk pengadaan/pembelian B3, pemasok (supplier) sudah melampirkan MSDS. (D,O,W)	D O W	Bukti pelaksanaan pengadaan pembelian B# disertai dengan MSDS yang tersedia di setiap tempat penyimpanan B3 sesuai PKPO 3 Lihat tempat penyimpanan B3 dan MSDSnya • Penanggung jawab program manajemen risiko/K3 RS • Penanggung jawab unit kerja terkait • Kepala farmasi/Kepala laboratorium/Kepala radiologi	10 5 0	TL L T S T T
4. Petugas telah menggunakan APD yang benar pada waktu menangani	O	1) Lihat ketersediaan dan penggunaan APD yang benar pada waktu menangani	10 5	TL TS
(handling) B3 dan limbahnya dan di area tertentu juga sudah ada eye washer. (lihat juga AP.5.3.1) (O,W)	W	(handling) B3 dan limbahnya 2) Lihat ketersediaan eye washer ditempat penyimpanan B3 cair • Penanggung jawab program manajemen risiko/K3 RS • Penanggung jawab unit kerja terkait	0	TT

5. B3 dan limbahnya sudah diberi label/rambu-rambu sesuai peraturan dan perundang-undangan. (lihat juga PKPO.3 EP 2) (O,W)	O W	Lihat label B3 ditempat penyimpanan B3 dan limbahnya • Penanggung jawab program manajemen risiko/K3 RS • Penanggung jawab unit kerja terkait	10 5 0	TL TS TT
6. Ada laporan dan analisis tentang tumpahan, paparan/pajanan (exposure) dan insiden lainnya. (D,W)	D W	Bukti laporan tumpahan, paparan/pajanan (exposure) dan insiden lainnya. • Penanggung jawab program manajemen risiko/K3 RS • Penanggung jawab unit kerja terkait	10 5 0	TL TS TT
7. Ada bukti dokumentasi persyaratan yang meliputi izin, lisensi atau ketentuan persyaratan lainnya. (D,W)	D W	Bukti izin IPAL, izin TPS B3, izin incinerator/ MOU dengan pihak ketiga bila pengolahan B3 dilakukan oleh pihak lain, beserta izin transporter • Penanggung jawab program manajemen risiko/K3 RS • Penanggung jawab unit kerja terkait	10 5 0	TL TS TT
Standar MFK 5.1 Rumah Sakit mempunyai sistem penyimpanan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun cair dan padat yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				
Maksud dan tujuan MFK 5.1 : Lihat SNARS 1				
Elemen Penilaian MFK 5.1	Telusur		Skor	
1. RS mempunyai regulasi untuk penyimpanan dan pengolahan limbah B3 secara benar dan aman sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan (<i>lihat juga AP.6.2, EP 4, MFK. 1 EP 3</i>) (R)	R	Sesuai MFK 5 EP 1	10 - 0	TL - T T
2. Penyimpanan limbah B3 sudah mempunyai izin TPS B3 yang masih berlaku dan sesuai dengan perundang – undangan.(D,O,W)	D O W	Bukti izin TPS B3 masih berlaku Lihat TPS B3 Staf terkait	10 - 0	TL - T T
3. Rumah Sakit sudah mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan izin yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang – undangan (D,O,W)	D O W	Bukti izin IPAL atau izin pembuangan limbah cair (IPLC) Lihat IPAL RS • Penanggung jawab sanitasi RS • Petugas pelaksana IPAL/staf terkait	10 - 0	TL - T T



4. RS mempunyai Instalasi Pengolah B3 dengan izin yang masih berlaku atau melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan izin sebagai transporter dan pengolah B3 yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan (D,O,W)	D	Bukti izin pengolah limbah B3 atau bukti MOU dengan pihak ketiga yang mempunyai :	10	T
	O	1) izin operasional pihak ketiga 2) izin transporter disertai manifest/ buktipemusnahan pihak ketiga	5	L
	W	Lihat dokumen terkait pengelolaan limbah B3/lokasi pengelolaan limbah B3 di RS • Penanggung jawab sanitasi RS • Petugas pelaksana IPAL/staf terkait	0	T S T T



KESIAPAN PENANGGULANGAN BENCANA				
Standar MFK 6 RS mengembangkan, memelihara, program manajemen disaster untuk menanggapi keadaan disaster dan bencana alam atau lainnya yang memiliki potensi terjadi dimasyarakat				
Maksud dan tujuan MFK 6 : Lihat SNARS 1 Manajemen Disaster antara lain berisi proses : a) menentukan jenis, kemungkinan terjadi dan konsekuensi bahaya, ancaman dan kejadian b) menentukan integritas struktural di lingkungan pelayanan pasien yang ada dan bila terjadi bencana c) menentukan peran rumah sakit dalam peristiwa/kejadian tersebut d) menentukan strategi komunikasi pada waktu kejadian e) mengelola sumber daya selama kejadian, termasuk sumber-sumber alternatif f) mengelola kegiatan klinis selama kejadian, termasuk tempat pelayanan alternatif pada waktu kejadian g) mengidentifikasi dan penetapan peran dan tanggung jawab staf selama kejadian (juga lihat MFK 11.1 EP 4) h) mengelola keadaan darurat ketika terjadi konflik antara tanggung jawab pribadi staf dengan tanggung jawab rumah sakit untuk tetap menyediakan pelayanan pasien. Ruang dekontaminasi di IGD sesuai peraturan perundang - undangan sebagai berikut : 1) ruangan ini ditempatkan di sisi depan/luar ruang gawat darurat atau terpisah dengan ruang gawatdarurat 2) pintu masuk menggunakan jenis pintu <i>swing</i> membuka ke arah dalam dan dilengkapi dengan alatpenutup pintu otomatis 3) bahan penutup pintu harus dapat mengantisipasi benturan-benturan brankar 4) bahan penutup lantai tidak licin dan tahan terhadap air 5) konstruksi dinding tahan terhadap air sampai dengan ketinggian 120 cm dari permukaan lantai 6) ruangan dilengkapi dengan wastafel (<i>sink</i>) dan pancuran air (<i>shower</i>)				
Elemen Penilaian MFK 6	Telusur			Skor
1. RS mempunyai regulasi manajemen disaster meliputi a) sampai h) di maksud dan tujuan.(R)	R	1) Regulasi tentang manajemen disaster RS 2) Regulasi tentang adanya ruang dekontaminasi dalam pedoman pelayanan IGD sesuai MFK 6 EP 4	10 - 0	TL - T T
2. RS mengidentifikasi bencana internal dan eksternal yang besarseperti keadaan darurat di masyarakat, wabah dan bencanaalam atau bencana lainnya, serta kejadian wabah besar yang bisa menyebabkan terjadinya risiko yang signifikan. (D,W)	D W	Bukti identifikasi risiko bencana internal dan eksternal, berupa hasil <i>hazard and vulnerabilityassessment</i> (HVA) • Tim Penanggulangan bencana RS • Penanggungjawab manajemen risiko • Tim K3RS	10 5 0	T L T S T T
3. Rumah sakit telah melakukan <i>selfassessment</i> kesiapan menghadapi bencana dengan menggunakan hospital safety index dari WHO. (D,W)	D W	Bukti pelaksanaan <i>Self Assessment Hospital Safety Index</i> • Tim Penanggulangan bencana RS/Tim	10 - 0	TL - T T



		K3RS • Penanggung jawab manajemen risiko		
4. Instalasi gawat darurat telah mempunyai ruang dekontaminasi sesuai dengan 1) sampai dengan 6) di maksud dan tujuan. (D,O,W)	D O W	Bukti denah ruang dekontaminasi Lihat fasilitas dekontaminasi di IGD • Ka IGD • Staf IGD	10 5 0	T L T S T T
Standar MFK 6.1				
RS melakukan simulasi penanganan/ menanggapi kedaruratan, wabah dan bencana				
Maksud dan tujuan MFK 6.1 : Lihat SNARS 1				
Elemen Penilaian MFK 6.1	Telusur		Skor	
1. Seluruh program, atau setidaknya elemen-elemen kritis program dari c) hingga h) di maksud dan tujuan MFK 6 disimulasikan setiap tahun. (D, W)	D W	Bukti pelaksanaan simulasi kesiapan menghadapi kedaruratan, wabah dan bencana • Kepala unit terkait • Tim penanggulangan bencana RS • Staf RS • Peserta simulasi	10 5 0	T L T S T T
2. Pada akhir setiap simulasi, dilakukan diskusi (debriefing) mengenai simulasi tersebut dan dibuat laporan dan tindak lanjut (D,W)	D W	Bukti pelaksanaan diskusi (debriefing) • Kepala unit terkait • Tim penanggulangan bencana RS • Staf RS • Peserta simulasi	10 - 0	T L - T T
3. Peserta simulasi adalah semua pegawai/staf rumah sakit, pegawai kontrak dan pegawai dari tenant/penyewa lahan. (D,W)	D W	Bukti daftar peserta simulasi • Diklat • Peserta simulasi	10 5 0	T L T S T T
PROTEKSI KEBAKARAN (FIRE SAFETY)				
Standar MFK 7				
RS merencanakan dan menerapkan suatu program untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyediaan sarana evakuasi yang aman dari fasilitas sebagai respons terhadap kebakarandan keadaan darurat lainnya.				



Maksud dan tujuan MFK 7 : Lihat

SNARS 1 Asesmen risiko meliputi :

- tekanan dan risiko lainnya di kamar operasi
- sistem pemisahan (pengisolasian) dan kompartemenisasi pengendalian api dan asap
- daerah berbahaya (dan ruang di atas langit-langit di seluruh area) seperti kamar linen kotor, tempat pengumpulan sampah, ruang penyimpanan oksigen
- sarana evakuasi
- dapur yang memproduksi dan peralatan masak
- londri dan linen
- sistem tenaga listrik darurat dan peralatan
- gas medis dan komponen sistem vakum

Berdasarkan hasil asesmen risiko rumah sakit agar menyusun program untuk:

- pencegahan kebakaran melalui pengurangan risiko, seperti penyimpanan dan penanganan bahan-bahan mudah terbakar secara aman, termasuk gas-gas medis yang mudah terbakar seperti oksigen;
- penanganan bahaya yang terkait dengan konstruksi apapun, di atau yang berdekatan dengan bangunan yang ditempati pasien
- penyediaan sarana evakuasi yang aman dan tidak terhalangi bila terjadi kebakaran;
- penyediaan sistem peringatan dini, deteksi dini, seperti detektor asap, alarm kebakaran, dan patroli kebakaran (*fire patrols*)
- penyediaan mekanisme pemadaman api, seperti selang air, bahan kimia pemadam api (*chemical suppressants*), atau sistem *sprinkler*.

Elemen Penilaian MFK 7	Telusur		Skor	
1. Rumah sakit mempunyai program proteksi kebakaran (<i>fire safety</i>) yang memastikan bahwa semua penghuni rumah sakit selamat dari bahaya api, asap atau keadaan darurat non kebakaran lainnya meliputi 1) sampai 5) yang ada di maksud dan tujuan. (R)	R	Program tentang proteksi kebakaran	10 - 0	TL - T T
2. Rumah sakit telah melakukan asesmen risiko kebakaran yang tertulis, termasuk saat terdapat proyek pembangunan di dalam atau berdekatan dengan fasilitas rumah sakit meliputi a) sampai dengan h) di maksud dan tujuan. (D,W)	D W	Bukti hasil asesmen risiko kebakaran/ <i>fire risk safety assessment</i> (FRSA) antara lain berupa ceklis asesmen risiko kebakaran Penanggung jawab/Tim kebakaran RS/Tim penanggulangan bencana/K3RS	10 - 0	TL - T T
3. Rumah sakit telah menindaklanjuti hasil asesmen risiko kebakaran. (D,O,W)	D O	Bukti tindak lanjut asesmen risiko kebakaran/ <i>fire risk safety assessment</i> (FRSA) Lihat proteksi kebakaran aktif dan pasif	10 5 0	T L T S T T
	W	Penanggung jawab/Tim kebakaran RS/Tim penanggulangan bencana		

4. Rumah sakit mempunyai sistem deteksi dini (smoke detector dan heat detector) dan alarm kebakaran sesuai dengan peraturan perundang - undangan (O,W)	O	Lihat fasilitas sistem deteksi dini (smoke detector dan heat detector) dan alarm kebakaran	10	T
	W	Penanggung jawab /Tim Kebakaran RS/Tim Penanggulangan bencana/K3RS	5 0	L T S T T
5. Rumah sakit mempunyai sistem kebakaran aktif yang meliputi, sprinkle, APAR, hidran dan pompa kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan. (O,W)	O	Lihat fasilitas sistem kebakaran aktif antara lain: sprinkle, APAR, hidran dan pompa kebakaran.	10	T
	W	Penanggung jawab/Tim Kebakaran RS/Tim Penanggulangan bencana/K3RS	5 0	L T S T T
6. Rumah sakit mempunyai jalur evakuasi yang aman dan bebas hambatan bila terjadi kebakaran dan kedaruratan bukan kebakaran. (O, W)	O	Lihat jalur evakuasi	10	T
	W	Penanggung jawab /Tim Kebakaran RS/Tim Penanggulangan bencana	5 0	L T S T T

Standar MFK 7.1

RS menguji secara berkala rencana proteksi kebakaran dan asap, termasuk semua alat yang terkait dengandeteksi dini dan pemadaman serta mendokumentasikan hasil ujinya.

Maksud dan tujuan MFK 7.1 : Lihat SNARS 1

Elemen Penilaian MFK 7.1	Telusur		Skor	
1. Semua staf mengikuti pelatihan penanggulangan kebakaran minimal 1 (satu) kali dalam setahun (Lihat juga MFK.11 sampai dengan MFK 11.3). (D,W)	D	Bukti pelaksanaan pelatihan penanggulangankebakaran	10	T
	W	- Staf RS - Diklat	5 0	L T S T T
2. Staf dapat memperagakan cara membawa pasien ketempat amandan mendemonstrasikan bagaimana cara menyelamatkan pasien. (S,W)	S	Peragaan evakuasi pasien ketempat aman	10	T
	W	Staf RS	5 0	L T S T T
3. Sistem dan peralatan pemadam kebakaran diperiksa, diujicoba dan dipelihara sesuai dengan peraturanperundang-undangan dan didokumentasikan (D,W)	D	Bukti pemeriksaan, uji coba, dan pemeliharaanperalatan pemadam kebakaran	10	T
	W	IPSRS/Bagian umum/K3RS	5 0	L T S T T

Standar MFK 7.2

RS merupakan kawasan tanpa rokok dan asap rokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan tujuan MFK.7.2 : Lihat SNARS 1

Elemen Penilaian MFK 7.2	Telusur		Skor	
--------------------------	---------	--	------	--

1. Rumah sakit mempunyai regulasi tentang rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok dan asap rokok, larangan merokok bagi pasien, keluarga, pengunjung dan staf, termasuk larangan menjual rokok di lingkungan rumah sakit. (R)	R	Regulasi tentang penetapan RS sebagai kawasan bebas rokok	10 - 0	TL - T T
2. Ada bukti pelaksanaan dan evaluasi dari regulasi tersebut. (D,O,W)	D O W	Bukti evaluasi kepatuhan larangan merokok Lihat lingkungan RS • Staf RS/K3RS/Satpam • Pengunjung RS	10 5 0	T L T S T T
PERALATAN MEDIS				
Standar MFK 8 RS merencanakan dan mengimplementasikan program untuk pemeriksaan, uji coba dan pemeliharaan				
peralatan medis dan mendokumentasikan hasilnya.				
Maksud dan tujuan MFK 8 : Lihat SNARS 1 Untuk menjamin peralatan medis dapat digunakan dan layak pakai maka rumah sakit perlu melakukan : a) melakukan inventarisasi peralatan medis yang meliputi peralatan medis yang dimiliki oleh RS, peralatan medis kerja sama operasional (KSO) milik pihak lain b) melakukan pemeriksaan peralatan medis secara teratur c) melakukan uji fungsi peralatan medis sesuai penggunaan dan ketentuan pabrik d) melaksanakan pemeliharaan preventif dan kalibrasi				
Elemen Penilaian MFK 8	Telusur		Skor	
1. RS mempunyai regulasi pengelolaan peralatan medis yang digunakan di rumah sakit meliputi a) sampai dengan d) di maksud dan tujuan (lihat juga AP.5.5, dan AP.6.5). (R)	R	Regulasi tentang pengelolaan peralatan medis disertai program pemeliharaan preventif dan kalibrasi sesuai EP 5	10 - 0	TL - T T
2. Ada daftar inventaris dan identifikasi risiko untuk seluruh peralatan medis yang digunakan di rumah sakit (lihat juga AP.5.5, dan AP.6.5). (D,W)	D W	1) Bukti daftar inventaris peralatan medis 2) Bukti identifikasi risiko peralatan medis Penanggung jawab Peralatan Medis/IPSR/K3RS	10 5 0	T L T S T T
3. Ada bukti peralatan medis diperiksa secara teratur (lihat juga AP.5.5, dan AP.6.5). (D,O,W)	D O W	Bukti ceklis dan hasil pemeriksaan peralatan medis Lihat fisik peralatan medis di unit pelayanan • Penanggung jawab peralatan medis/IPSR • Operator peralatan medis • Kepala unit pelayanan	10 5 0	T L T S T T

4. Peralatan medis diuji fungsi sejak baru dan sesuai umur, penggunaan dan rekomendasi pabrik (lihat juga AP.5.5, dan AP.6.5) (D, W)	D W	Bukti pelaksanaan dan hasil uji fungsi peralatan medis • Penanggung jawab peralatan medis/IPSRS • Operator peralatan medis • Kepala unit pelayanan	10 5 0	T L T S T T
5. Ada program pemeliharaan preventif termasuk kalibrasi (lihat juga AP.5.5, dan AP.6.5).(D,O,W)	D O W	Bukti pelaksanaan pemeliharaan preventif dan kalibrasi peralatan medis Lihat bukti pemeliharaan preventif dan kalibrasi • Penanggung jawab peralatan medis/IPSRS • Teknisi alat medis/operator peralatan medis • Kepala unit pelayanan	10 5 0	T L T S T T
6. Staf yang kompeten melaksanakan kegiatan ini.(D,W)	D W	Bukti pelaksanaan kegiatan oleh staf yang kompeten (yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat pelatihan) • Penanggung jawab peralatan medis/IPSRS • Teknisi alat medis	10 5 0	T L T S T T
Standar MFK 8.1 RS memiliki sistem untuk memantau dan bertindak bila ada pemberitahuan peralatan medis yang berbahaya, <i>recall</i> , laporan insiden, masalah dan kegagalan				
Maksud dan tujuan MFK 8.1 : Lihat SNARS 1				
Elemen Penilaian MFK 8.1		Telusur		Skor
1. RS mempunyai sistem pemantauan dan bertindak terhadap pemberitahuan mengenai peralatan medis yang berbahaya, <i>recall</i> /penarikan kembali, laporan insiden, masalah, dan kegagalan pada peralatan medis. (R)	R	Regulasi tentang pemantauan dan penarikan kembali (<i>recall</i>) peralatan medis (PAB 7.4)	10 - 0	TL - T T
2. RS membahas pemberitahuan peralatan medis yang berbahaya, alat medis dalam penarikan (<i>under recall</i>), laporan insiden, masalah dan kegagalan pada peralatan medis. (D,W)	D W	Bukti pertemuan yang membahas hasil pemantauan peralatan medis yang berbahaya, alat medis dalam penarikan (<i>under recall</i>), laporan insiden, masalah dan kegagalan pada peralatan medis disertai bukti hasil pemantauan • Kepala bidang penunjang medis • Para pimpinan terkait • Penanggung jawab peralatan medis • Operator peralatan medis	10 5 0	TL TS TT

3. RS telah melaporkan seluruh insiden keselamatan sesuai peraturan perundang-undangan bila terjadi kematian, cedera serius atau penyakit yang disebabkan oleh peralatan medis. (D,W)	D W	Bukti pelaporan insiden keselamatan (sentinel) terkait peralatan medis ke internal dan eksternal ke Komite Nasional Keselamatan Pasien RS dan KARS • Penanggung jawab peralatan medis • Ka unit kerja dimana insiden keselamatan terjadi • Operator peralatan medis/teknisi peralatan medis	10 5 0	TL TS TT
SISTEM UTILITAS (SISTEM PENDUKUNG)				
Standar MFK 9 RS menetapkan dan melaksanakan program untuk memastikan semua sistem utilitas (sistem penunjang) berfungsi efisien dan efektif yang meliputi pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan dari sistem utilitas.				
Maksud dan tujuan MFK 9 : Lihat SNARS 1 Regulasi pengelolaan sistem utilitas meliputi: - Ketersediaan air dan listrik 24 jam setiap hari dan dalam waktu tujuh hari dalam seminggu secara terus menerus. - Membuat daftar inventaris komponen-komponen sistem utilitas dan memetakan pendistribusiannya dan melakukan update secara berkala. - Pemeriksaan dan pemeliharaan serta perbaikan semua komponen utilitas yang ada di daftar inventaris. - Jadwal pemeriksaan, testing, pemeliharaan semua sistem utilitas berdasar kriteria seperti rekomendasi dari pabrik, tingkat risiko dan pengalaman rumah sakit. - Pelabelan pada tuas-tuas kontrol sistem utilitas untuk membantu pemadaman darurat secara keseluruhan atau sebagian - Komponen listrik yang digunakan rumah sakit sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan				
Elemen Penilaian MFK 9	Telusur		Skor	
1. Rumah sakit mempunyai regulasi pengelolaan sistem utilitas meliputi sekurang-kurangnya a) sampai dengan f) di maksud dan tujuan. (R)	R	Regulasi tentang pengelolaan sistem utilitas	10 - 0	TL - T T
2. RS mempunyai daftar inventaris komponen-komponen sistem utilitasnya dan memetakan pendistribusiannya. (D,W)	D W	Bukti daftar inventaris sistem utilitas dan lokasinya • Bagian umum/rumah tangga • Ka IPSRS/Penanggung jawab utilitas	10 5 0	T L T S T T
3. RS telah melaksanakan jadwal pemeriksaan, testing, pemeliharaan semua sistem utilitas berdasar kriteria seperti rekomendasi dari pabrik, tingkat risiko dan pengalaman rumah sakit sendiri serta sudah dilaksanakan.	D W	1) Bukti hasil pemeriksaan 2) Bukti hasil testing/pengujian 3) Bukti hasil pemeliharaan sistem utilitas Ka IPSRS/ Penanggung jawab utilitas	10 5 0	T L T S T T

(D,W)				
4. RS telah memberikan label pada tuas-tuas kontrol sistem utilitas untuk membantu pemadaman darurat secara keseluruhan atau sebagian. (O,W)	O W	Lihat label pada tuas-tuas kontrol utilitas Ka IPSRS/ Penanggung jawab utilitas	10 5 0	T L T S T T
Standar MFK 9.1				
Dilakukan pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem utilitas				
Maksud dan tujuan MFK 9.1 : Lihat SNARS 1				
Elemen Penilaian MFK 9.1	Telusur		Skor	
1. RS mempunyai regulasi tentang inventarisasi, pemeliharaan, inspeksi dengan kriteria yang ditentukan untuk sistem utilitas penting yang dilakukan secara berkala (R)	R	Regulasi tentang sistem utilitas penting/utama	10 - 0	TL - T T
2. RS mempunyai daftar sistem utilitas di rumah sakit dan daftar sistem utilitas penting (D,W)	D W	1) Bukti daftar inventaris sistem utilitas 2) Bukti daftar inventaris sistem utilitas penting/ utama Ka IPSRS/PJ utilitas	10 5 0	T L T S T T
3. Sistem utilitas dan komponen telah diinspeksi secara teratur/berdasarkan kriteria yang disusun RS (D,O)	D O	Bukti inspeksi sistem utilitas penting: 1) Bukti form ceklis 2) Bukti pelaksanaan inspeksi Lihat ke sistem utilitas penting di RS	10 5 0	T L T S T T
4. Sistem utilitas dan komponen diuji secara teratur berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. (D,W)	D W	Bukti hasil uji coba sistem utilitas penting Ka IPSRS/Penanggung jawab utilitas	10 5 0	T L T S T T
5. Sistem utilitas dan komponen dipelihara berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. (D,O)	D O	Bukti pelaksanaan pemeliharaan/bukti hasil pemeliharaan sistem utilitas penting Lihat ke sistem utilitas penting di RS	10 5 0	T L T S T T
6. Sistem utilitas dan komponen diperbaiki bila diperlukan (D,O)	D O	Bukti perbaikan sistem utilitas Lihat ke sistem utilitas penting di RS	10 5 0	TL T S T T

Standar MFK 9.2

Sistem utilitas rumah sakit menjamin tersedianya air bersih dan listrik sepanjang waktu serta menyediakan sumber alternatif persediaan air dan tenaga listrik jika terjadi terputusnya sistem, kontaminasi atau kegagalan.

Maksud dan tujuan MFK 9.2 : Lihat SNARS 1

Untuk mempersiapkan diri terhadap keadaan darurat seperti ini, rumah sakit agar mempunyai regulasi yang antara lain meliputi :

- mengidentifikasi peralatan, sistem, dan area yang memiliki risiko paling tinggi terhadap pasien dan staf (sebagai contoh, rumah sakit mengidentifikasi area yang membutuhkan penerangan, pendinginan (lemari es), bantuan hidup/Ventilator, dan air bersih untuk membersihkan dan sterilisasi alat)
- menyediakan air bersih dan listrik 24 jam setiap hari dan 7 hari seminggu.
- menguji ketersediaan dan kehandalan sumber tenaga listrik dan air bersih darurat /pengganti/backup
- mendokumentasikan hasil-hasil pengujian
- memastikan bahwa pengujian sumber alternatif air bersih dan listrik dilakukan setidaknya setiap 6 bulan atau lebih sering jika dipersyaratkan oleh peraturan perundangan di daerah, rekomendasi produsen, atau kondisi dari sumber listrik dan air.

Elemen Penilaian MFK 9.2	Telusur		Skor	
1. RS mempunyai regulasi tentang sistem utilitas yang meliputi a) sampai dengan e) dimaksud dan tujuan. (R)	R	Regulasi tentang sistem utilitas termasuk kerjasama dengan penyedia air bersih bila terjadi gangguan	10 - 0	TL - T T
2. Air bersih harus tersedia selama 24 jam setiap hari, 7 hari dalam seminggu. (O,W)	O W	Lihat penampungan persediaan air bersih - Penanggung jawab air bersih RS - Staf RS - Pasien	10 5 0	T L T S T T
3. Listrik tersedia 24 jam setiap hari, 7 hari dalam seminggu. (O,W)	O	Lihat sumber listrik utama dan sumber listrik alternatif di RS termasuk UPS pada alat-alat tertentu misalnya ventilator dan server sentral	10 5 0	T L T S TT
	W	- Penanggung jawab listrik RS - Staf RS - Pasien		
4. RS mengidentifikasi area dan pelayanan yang berisiko paling tinggi bila terjadi kegagalan listrik atau air bersih terkontaminasi atau terganggu. (D,W)	D W	1) Bukti identifikasi area berisiko bila terjadi kegagalan listrik 2) Bukti identifikasi area berisiko bila terjadi kegagalan air - Ka IPSRS - Ka Sanitasi	10 5 0	T L T S T T
5. RS berusaha untuk mengurangi risiko bila hal itu terjadi (tata kelola risiko). (D,W)	D W	Bukti telah dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi risiko bila terjadi kegagalan listrik maupun air di area paling berisiko, termasuk kerjasama dengan penyedia air bersih bila terjadi gangguan	10 5 0	T L T S T T

		• Ka IPSRS • Ka Sanitasi		
6. RS mempunyai sumber listrik dan air bersih alternatif dalam keadaan emergensi. (D,O,W)	D O W	1) Bukti pelaksanaan kajian kebutuhan sumber listrik dan air bersih alternatif dalam keadaan emergensi 2) Bukti kontrak kerjasama dengan penyedia air bersih bila terjadi gangguan Lihat ke genset dan sumber air bersih alternatif • Ka IPSRS • Ka Sanitasi	10 5 0	T L T S T T
Standar MFK 9.2.1				
Rumah sakit melakukan uji beban listrik dan sumber air alternatif.				
Maksud dan tujuan MFK 9.2.1 : Lihat SNARS 1				
Elemen Penilaian MFK 9.2.1	Telusur		Skor	
1. RS mempunyai regulasi uji coba sumber air bersih dan listrik alternatif sekurangnya 6 bulan sekali atau lebih sering bila diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau oleh kondisi sumber air (R)	R	Regulasi tentang uji coba sumber air bersih dan listrik alternatif	10 - 0	TL - T T
2. RS mendokumentasi hasil uji coba sumber air bersih alternatif tersebut. (D,W)	D W	Bukti dokumentasi pelaksanaan uji coba sumber air bersih alternatif • Ka unit Sanitasi • Petugas air bersih	10 5 0	T L T S T T
3. RS mendokumentasi hasil uji sumber listrik alternatif tersebut. (D,W)	D W	Bukti dokumentasi pelaksanaan uji coba sumber listrik alternatif • Ka IPSRS • Petugas genset	10 5 0	T L T S T T
4. RS mempunyai tempat dan jumlah bahan bakar untuk sumber listrik alternatif yang mencukupi. (O,W)	O W	Lihat tempat penyimpanan bahan bakar untuk genset Petugas genset	10 5 0	T L T S T T
Standar MFK 9.3				
RS melakukan pemeriksaan air bersih dan air limbah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang - undangan.				
Maksud dan tujuan MFK 9.3 : Lihat SNARS 1				
RS harus mempunyai regulasi sekurang-kurangnya meliputi:				
a) Pelaksanaan monitoring mutu air bersih paling sedikit setiap 1 tahun sekali. Untuk pemeriksaan kimia				



minimal setiap 6 bulan sekali atau lebih sering tergantung ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi sumber air, dan pengalaman sebelumnya dengan masalah mutu air. Hasil pemeriksaan didokumentasikan.

- b) Pemeriksaan air limbah dilakukan setiap 3 bulan atau lebih sering tergantung peraturan perundang-undangan, kondisi air limbah, dan hasil pemeriksaan air limbah terakhir. Hasil pemeriksaan didokumentasikan
- c) Pemeriksaan mutu air yang digunakan untuk dialisis ginjal setiap bulan, untuk menilai pertumbuhan bakteri dan endotoksin.
- d) Pemeriksaan tahunan untuk menilai kontaminasi zat kimia. Hasil pemeriksaan didokumentasikan
- e) Melakukan monitoring hasil pemeriksaan air dan melakukan perbaikan bila diperlukan.

Elemen Penilaian MFK 9.3	Telusur		Skor	
1. RS mempunyai regulasi sekurang-kurangnya meliputi a) sampai dengan e) di maksud dan tujuan (R)	R	Regulasi tentang pemeriksaan air bersih (termasuk air minum) dan air limbah meliputi a)s/d e) di maksud dan tujuan	10 5 0	T L T S T T
2. RS telah melakukan monitoring mutu air sesuai dengan peraturanperundang-undangan dan terdokumentasi (D,W)	D W	Bukti hasil pemeriksaan mutu air bersihtermasuk air minum Petugas Sanitasi	10 5 0	T L T S T T
3. RS telah melakukan pemeriksaan air limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi. (D,W)	D W	Bukti hasil pemeriksaan mutu air limbah Petugas Sanitasi	10 5 0	T L T S T T
4. RS telah melakukan pemeriksaan mutu air yang digunakan untuk dialisis ginjal yang meliputi pertumbuhan bakteri dan endotoksin dan kontaminasi zat kimia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi. (D,W)	D W	Bukti hasil pemeriksaan mutu air yangdigunakan untuk dialisis Petugas sanitasi/unit hemodialisa	10 5 0	T L T S T T
5. RS telah menindak lanjuti hasil pemeriksaan mutu air yang bermasalah dan didokumentasikan. (D, W)	D W	Bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan Petugas sanitasi	10 5 0	T L T S T T

PROGRAM MONITORING FASILITAS				
Standar MFK 10 Rumah sakit mengumpulkan data dari setiap program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan untuk mendukung rencana mengganti atau meningkatkan fungsi (<i>upgrade</i>) teknologi medik, peralatan, sistem dan menurunkan risiko di lingkungan.				
Maksud dan tujuan MFK 10 : Lihat SNARS 1				
Elemen Penilaian MFK 10	Telusur		Skor	
1. RS mempunyai regulasi Sistem pelaporan data insiden/kejadian/kecelakaan dari setiap program manajemen risiko fasilitas (R)	R	Regulasi tentang sistem pelaporan data insiden/ kejadian/kecelakaan dari setiap program manajemen risiko fasilitas	10 - 0	TL - T T
2. Ada laporan data insiden/kejadian/kecelakaan dari setiap program manajemen risiko fasilitas dan sudah dianalisis. (D,W)	D W	Bukti laporan insiden keselamatan terkait manajemen risiko fasilitas dan hasil analisis • Ka Tim K3/ Penanggung jawab manajemen risiko/kepala unit/staf RS • Komite PMKP/Tim Keselamatan Pasien RS	10 5 0	T L T S T T
3. Hasil analisis sudah ditindaklanjuti dengan mengganti atau meningkatkan fungsi (<i>upgrade</i>) teknologi medis, peralatan, sistem dan menurunkan risiko di lingkungan. (D,O,W)	D O W	Bukti tindak lanjut dari hasil analisis Lihat kondisi sistem peralatan dan lingkungan kerja • Ka Tim K3/ Penanggung jawab manajemen risiko/kepala unit/staf RS • Komite PMKP/Tim Keselamatan Pasien RS	10 5 0	T L T S T T
4. Seorang atau lebih individu yang ditunjuk mengawasi pelaksanaan program manajemen risiko fasilitas telah membuat laporan kepada direktur rumah sakit setiap 3 bulan (lihat juga MFK 3) (D,W)	D W	Bukti pelaksanaan pengawasan dan pelaporan program manajemen risiko fasilitas • Ka Tim K3/ Penanggung jawab manajemen risiko • Komite PMKP/Tim Keselamatan Pasien RS	10 5 0	T L T S T T
PENDIDIKAN STAF				
Standar MFK 11 RS menyelenggarakan edukasi, pelatihan, tes dan simulasi bagi semua staf tentang peranan mereka dalam memberikan fasilitas yang aman dan efektif.				
Maksud dan tujuan MFK 11 : Lihat SNARS 1				
Elemen Penilaian MFK 11	Telusur		Skor	
1. RS mempunyai program pelatihan tentang manajemen fasilitas dan keselamatan (R)	R	Program pelatihan MFK	10 - 0	TL - T T

2. Edukasi diadakan setiap tahun mengenai setiap komponen dari program manajemen fasilitas dan keselamatan untuk menjamin semua staf dapat melaksanakan dengan efektif tanggung jawabnya. (Lihat juga AP.5.3;AP.6.3) (D,W)	D W	Bukti pelaksanaan pelatihan program MFK - Ka Tim K3/ Penanggung jawab manajemen risiko - Bidang diklat	10 5 0	T L T S T T
3. Edukasi diikuti oleh pengunjung, suplier, pekerja kontrak dan lain- lain sesuai regulasi rumah sakit (D,W)	D W	Bukti pelaksanaan edukasi terhadap pengunjung, suplier, pekerja kontrak dan lain-lain - Ka Tim K3/PJ manajemen risiko - Bidang diklat - Pengunjung - Suplier	10 5 0	T L T S T T
4. Pengetahuan staf dites dan disimulasikan sesuai peran mereka dalam setiap program manajemen fasilitas. Kegiatan pelatihan dan hasil pelatihan setiap staf didokumentasikan. (D,W)	D W	Bukti evaluasi pelatihan berupa pre test dan post test pelatihan termasuk mampu mempragakan - Ka Tim K3/ Penanggung jawab manajemen risiko - Peserta pelatihan	10 5 0	T L T S T T

Standar MFK 11.1

Staf dilatih dan diberi pengetahuan tentang peranan mereka dalam program RS untuk proteksi kebakaran, keamanan dan penanggulangan bencana.

Maksud dan tujuan MFK 11.1 : Lihat SNARS 1

Elemen Penilaian MFK 11.1	Telusur		Skor	
1. Staf dapat menjelaskan dan/atau mempragakan peran mereka dalam menghadapi kebakaran. (W,S)	W S	Staf RS Peragaan oleh staf	10 5 0	T L T S T T
2. Staf dapat menjelaskandan/atau mempragakan tindakan untuk menghilangkan, mengurangi/ meminimalisir atau melaporkan tentang keselamatan, keamanan dan risiko lainnya.(W,S)	W S	Staf RS Peragaan oleh staf	10 5 0	T L T S T T
3. Staf dapat menjelaskan dan/atau mempragakan tindakan, kewaspadaan, prosedur dan partisipasi dalam penyimpanan, penanganan dan pembuangan gas medis, serta limbah B3. (W,S)	W S	Staf RS Peragaan oleh staf	10 5 0	T L T S T T
4. Staf dapat menjelaskan dan/atau mempragakan prosedur dan	W	Staf RS	10 5	TL TS

peran mereka dalam penanganan kedaruratan serta bencana internal atau eksternal (community). (W,S)	S	Peragaan oleh staf	0	TT
Standar MFK 11.2				
Staf dilatih untuk menjalankan dan memelihara peralatan medis dan sistem utilitas				
Maksud dan tujuan MFK 11.2 : Lihat SNARS 1				
Elemen Penilaian MFK 11.2	Telusur		Skor	
1. Staf diberi pelatihan untuk menjalankan peralatan medis sesuai uraian tugasnya dan dilakukan tes secara berkala. (D,W,S)	D	1) Bukti pelaksanaan pelatihan 2) Bukti tes yang dilakukan	10 5 0	T L T S T T
	W	- Penanggung jawab peralatan medis - Kepala bidang pelayanan/penunjang - Operator peralatan medis - Diklat		
	S	Peragaan oleh operator peralatan medis untuk menjalankan peralatan medis		
2. Staf diberi pelatihan untuk menjalankan sistem utilitas sesuai uraian tugasnya dan dilakukan tes secara berkala. (D,W,S)	D	1) Bukti pelaksanaan pelatihan 2) Bukti tes yang dilakukan	10 5 0	T L T S T T
	W	- Penanggung jawab sistem utilitas - Kepala bidang pelayanan/penunjang - Operator sistem utilitas - Diklat		
	S	Peragaan oleh operator sistem utilitas untuk menjalankan sistem utilitas		
3. Staf diberi pelatihan untuk memelihara peralatan medis sesuai uraian tugasnya dan dilakukan tes secara berkala. (D,W,S)	D	1) Bukti pelaksanaan pelatihan 2) Bukti tes yang dilakukan	10 5 0	T L T S T T
	W	- Penanggung jawab peralatan medis - Teknisi peralatan medis		
4. Staf diberi pelatihan untuk memelihara sistem utilitas sesuai uraian tugasnya dan dilakukan tes secara berkala. (D,W,S)	D	1) Bukti pelatihan 2) Bukti test yang dilakukan	10 5 0	T L T S T T
	W	- Teknisi sistem utilitas - Penanggung jawab sistem utilitas		
	S	Peragaan oleh teknisi sistem utilitas dalam pemeliharaan sistem utilitas		